THORAX · TH-04

Pneumopathies diffuses · ACR 2026

ACR AC Diffuse Lung Disease 2026
HRCT · suspicion initiale, exacerbation aiguë, surveillance · patterns ERS/ATS 2025

Principe ACR 2026 — Les pneumopathies diffuses (DLD, ou interstitielles) regroupent plusieurs centaines de syndromes touchant le parenchyme pulmonaire. L'**HRCT sans injection** est l'examen central : il caractérise le **pattern** (notamment **UIP** = fibrose usuelle interstitielle), que la **discussion multidisciplinaire** intègre pour améliorer précision diagnostique et confiance. Trois situations évaluées par l'ACR Appropriateness Criteria « Diffuse Lung Disease », révisé 2026 : suspicion initiale, décompensation aiguë, surveillance.

QUEL EXAMEN POUR QUELLE SITUATION ? (ACR 2026)

Suspicion initiale

- **Habituellement approprié** : **radiographie thoracique** (premier examen) + **scanner sans injection haute résolution (HRCT)**
- **Peut être approprié** : scanner avec injection · scanner standard sans injection
- **Habituellement inapproprié** : IRM (± gadolinium) · TEP-TDM · scanner injecté en HRCT

DLD confirmée · suspicion d'exacerbation ou d'aggravation aiguë

- **Habituellement approprié** : **radiographie** · **scanner sans injection** · **HRCT**
- **Peut être approprié** : scanner avec injection · **angioscanner** (rechercher une embolie pulmonaire)
- **Habituellement inapproprié** : IRM · TEP-TDM
- Chercher une cause réversible : **infection, embolie pulmonaire, pneumothorax, œdème cardiogénique** (voir le critère ACR « Acute Respiratory Illness »)

DLD confirmée · surveillance (sans aggravation aiguë)

- **Habituellement approprié** : **HRCT**
- **Peut être approprié** : radiographie · scanner standard sans injection
- **Habituellement inapproprié** : IRM · TEP-TDM · scanner avec injection
- L'intervalle n'est pas fixé par le critère : selon la maladie, sa sévérité et le contexte clinique (protocoles de suivi de chaque entité)

TECHNIQUE HRCT

- **Coupes fines** (≈ 1–1,5 mm), inspiration profonde, fenêtres parenchymateuses, **sans injection**
- Le gadolinium n'aide pas à caractériser un pattern ; l'injection ne se justifie que pour une autre question (masse, ADP, complication)
- Coupes en décubitus ventral si besoin : distinguer dépendance postérieure vs vraie fibrose sous-pleurale
- Coupes en expiration si suspicion de piègeage d'air (bronchiolite constrictive)

GRILLE DE LECTURE · CLASSIFICATION ERS/ATS 2025

Décrire avant de classer

- **Distribution** : sommets (apico-dorsale) vs bases ; centrale vs périphérique ; asymétrie
- **Patterns élémentaires** : réticulation, micronodules, verre dépoli, consolidation, lignes septales épaissies, kystes, honeycombing (rayon de miel)
- **UIP** : fibrose sous-pleurale et bibasale, prédominance basale, honeycombing, distorsion — pattern le plus important à reconnaître (diagnostic de FPI possible en HRCT typique, confirmé en discussion multidisciplinaire)
- Signes associés : ADP médiastinales (souvent réactionnelles), épanchement pleural, emphysème, atteinte des voies aériennes

Trois groupes ERS/ATS 2025

- **Patterns interstitiels** : pneumonies interstitielles (UIP, NSIP, PO/BOP, DIP, AIP…) et apparentés
- **Troubles de remplissage alvéolaire** : protéinose alvéolaire, hémorragie, pneumopathie lipidique…
- **Maladies rares ou non classées**
- Le scanner distingue des patterns à valeur pronostique et clinique — la corrélation au contexte (exposition, connectivite, médicaments, tabac) reste indispensable

PIÈGES

Radio
une radiographie normale n'exclut pas une pneumopathie diffuse — HRCT si suspicion persistante

Scanner injecté
un scanner injecté à coupes épaisses ne remplace pas une HRCT dédiée : reconstructions fines systématiques

TEP
la fixation TEP n'est pas spécifique d'un pattern : jamais pour caractériser une DLD

Comparaison
toujours comparer aux HRCT antérieures : la progression fait partie du suivi

Sources : ACR AC Diffuse Lung Disease : 2026 Update (JACR) – www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546144026003467 · ACR AC Search – Diffuse Lung Disease (tableaux 2026) – acsearch.acr.org/docs/3157911/Narrative/ · Patterns en imagerie des ILD – classification ERS/ATS 2025 (DIR 2026) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13530495/